EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 80670
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-14 12:10:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA MABEL SEPULVEDA PARRA			RUN	: 10.055.580-8
F.Nac	: 10-06-1965	Edad	: 58 AÑOS, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: Fundo La Encina Cam A M. Blanco			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 941683537		
Fecha Ingreso	: 2024-03-10	Fecha Egreso	: 2024-03-14 12:10:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R57.9-CHOQUE, NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Sepsis foco urinario en vias de resolucion (PNAg)
HIpotiroidismo
Tu medular (ependimoma)
HTA
TEP en TACO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec, descritos, consulta en SU el 09/03 por caudro de 3 dias de evolucion de CEG, fiebre, orinas de aspecto piurico. A su ingreso se describe hipoteensa, taquicardica, febril. Se inicia en primera instancia aporte de fluidos, con escasa respuesta, se decide inicio precoz de DVA. Sumado a toma de cultivos

Ex de lab al ingreso -> glicemia 123; crea 1,3; lactato 2; PCR 350,3; uremia 65; Na/K/Cl 132/3.2/99; Gb 11,8; Hb/Hcto 11.3/31.9; plaq 197000; segment 96%; INR 1,39, dimero D 7375,5, procalcitonina 71,92; GSV pH 7,44 orina nitritos (-), leucos 15-20, piocitos 40-50, placas de pus regular cantidad

En forma posterior se procede a reanimacion agresiva con fluidos, titulando a la baja BIC de norepinefrina, logrando estabilizacion de presiones. Se inicia terapia ATB de amplio espectro, se decide ingreso a medicina agudos para manejo de paciente.

Durante su estancia HDN estable, sin dolor, con parametros inflamatorios en franca disminucion. URC con desarrollo de E Coli BLEE (+), se procede a cambio de terapia ATB a carbapenemico

Examenes de lab 12/03 -> albumina 2,6; crea 0,5; lactato 0,9; uremia 31, Na/K/Cl 140/3.6/105; Gb 7.6; Hb/Hcto 11.1/30.7; plaq 247000; segment 78%; PCR 83,3

Paciente HDN estable, afebril, sin nuevos episodios de peak febril, con buena tolerancia a alimentacion VO, sin nuevos episodios de nauseas Y7o vomitos, diuresis registrada 2200 cc

Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs, yugulares planas
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen Blando, algo distendido, RHA (+), sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 4 hospitalzada, dia N° 2 de ertapenem, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Con cifras tencionales estables, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Continuar con terapia ATB establecida, se controlara con parametros inflamatorios dentro de 24 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentado 30°
2. Regimen hiposodico a tolerancia
3. Ertapenem 1 gr al dia EV por 5 dias
4. Omeprazol 40 mg al dia EV por 5 dias
5. Clexane 80 mg c/12 hrs SC por 5 dias
6. Levotiroxina 100 mcg, medio comp al dia VO
7. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 5 dias
8. Cuidados de enfermeria prevencion UPP
9. Examenes de control 15/03
10. CSV c/6hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO